

Какой вид желтухи сопровождается гемолитической анемией :{

- ~подпеченочная
 - ~энзимопатическая
 - ~печеночно-клеточная
 - =надпеченочная
 - ~никакая
- }

При какой желтухе в крови увеличивается непрямая и прямая функция билирубина :{

- ~гемолитической
 - =паренхиматозной
 - ~механической
 - ~энзимопатической
 - ~все перечисленное
- }

Почему при гепатитах нарушается сумеречное зрение :{

- ~недостаточность витамина Е
 - ~недостаточность витамина К
 - =недостаточность витамина А
 - ~недостаточность витамина D
 - ~все перечисленное
- }

Гемолитическая болезнь новорожденных объясняется :{

- ~иммунным конфликтом Т клеток с антигенами ребенка
- ~неполноценным плацентарным кровообращением
- ~эритроциты плода содержат Rh⁺ фактор
- =накоплением в крови антител против Rh⁺ фактора

~все перечисленное
}

Почему при печеночной патологии наблюдается лейкопения :{
~задерживается созревание лейкоцитов в костном мозге
~задерживается лейкопоэз
~все перечисленное
~недостаточность витамина В12
=развивается гиперспленизм
}

Для какой желтухи характерно появление в крови печеночных АЛТ и АСТ :{
~надпеченочной
~подпеченочной
=печеночно-клеточной
~все перечисленное
}

Какие из указанных соединений оказывают выраженное токсическое действие на организм :{
=непрямой билирубин
~прямой билирубин
~уробилиноген
~стеркобилиноген
~все перечисленное
}

Какие из указанных соединений оказывают выраженное токсическое действие на организм :{
=желчные кислоты
~билирубин прямой
~уробилиноген
~стеркобилиноген
~все перечисленное

}

Почему при печеночной недостаточности нарушается антимикробная функция :{

=снижается активность Купферовских клеток

~усиливается транспорт иммуноглобулинов в желчь

~уменьшается гамма-глобулиновая фракция крови

~сочетание (усиливается транспорт иммуноглобулинов в желчь),
(уменьшается гамма-глобулиновая фракция крови)

~из-за холестаза

}

Назовите внепеченочные причины печеночной недостаточности :{

~паразитарные поражения

~холестаз

=эндокринопатии

~наследственная недостаточность глюкорониилтрансферазы

~все перечисленное

}

Гепатозы являются результатом действия :{

~вирусов

~эхинокока

~гельминтов

=антибиотиков

~Т-клеточных реакций

}

Вирусные гепатиты А и Е передаются :{

~парентеральным способом

~половым контактом

=энтеральным способом

~трансфузией крови и ее препаратов

~все перечисленное

}

Укажите причину, имеющую наибольшее патогенное значение при печеночной коме :{

~нарушение процессов окисления

~нарушение переаминирования

=нарушение дезинтоксикации

~образование парных соединений

~холестаз

}

Характерными признаками выраженной надпеченочной желтухи являются :{

~повышение содержания прямого билирубина

=повышение непрямого билирубина

~холемиа

~увеличение содержания холестерина

~уменьшается содержания стеркобилиногена в кале

}

Назовите ведущий механизм образования пигментных камней в желчных путях :{

~коагуляция белков, поступивших в желч из поврежденных клеток слизистой пузыря

~повышении концентрации холестерина в желчи

~изменение холато-холестеринового коэффициента

=процессы гемолиза связанные с застоем

~воспаление желчного пузыря

}

Важным следствием патологии белкового обмена при ОПН является :{

~снижение аммиака в крови

=увеличение аммиака в крови

~снижение гамма-глобулинов крови

~увеличение бета-глобулинов крови

~все перечисленное

}

С чем связан синдром Жильбера при развитии паренхиматозной желтухи - :{

~с дефицитом глюкоронилтрансферазы

~с нарушением активности ферментов, обеспечивающие экскрецию прямого билирубина

=с нарушением захвата непрямого билирубина из крови гепатоцитами

~с нарушением оттока желчи в 12-перстную кишку

~с холангитом

}

Почему при механической желтухе возникает брадикардия :{

~повышается активность симпатической системы

~снижается активность парасимпатической системы

=повышается тонус ядер блуждающего нерва

~усиливается активность нерва Павлова

~стимулируется сосудодвигательный центр

}

Чем проявляется ахолический синдром :{

=стеатореей

~запорами

~избыточной моторикой кишечника
~рвотой
~повышением кислотности в желудке
}

При какой желтухе в крови увеличивается прямой билирубин :{
~надпочечной
~печеночной в поздней стадии
=подпеченочной
~энзимопатической
~надпочечной и энзимопатической
}

При какой желтухе увеличивается непрямой билирубин в крови :{
~паренхиматозной
=надпеченочной
~подпеченочной
~энзимопатической
~все перечисленное
}

Укажите причины усиления выделительной функции желудка :{

~гиперсекреция желудочного сока
~ахилия
=почечная недостаточность (уремия)
~полифагия
~все перечисленное
}

Укажите причины усиления всасывательной функции желудка :{
=застой пищи, гастриты
~язвенная болезнь 12-перстной кишки
~язвенная болезнь желудка
~дуодениты
~гепатиты различной этиологии
}

Укажите проявления панкреатического коллапса :{
=внезапное падение А/Д
~внезапное повышение А/Д
~внезапная потеря сознания
~аритмия
~тахикардия
}

Чем характеризуется парорексия :{
~возникновением неутолимого голода
~снижением аппетита
=склонностью к употреблению непищевых веществ
~полным отказом от пищи
~сочетание (снижением аппетита), (полным отказом от пищи)
}

Назовите вероятную причину нейродинамической анорексии :{
=торможение пищевого центра при болевых синдромах (почечная колика)
~сознательный отказ от пищи в связи с психическим заболеванием

~она обусловлена нарушением функции рецепторов пищеварительного тракта
~отрицательные эмоции, сильное возбуждение коры головного мозга
~снижение активности пищевого центра
(инфекции и интоксикации)
}

Укажите последствия патологического усиления всасывания в тонком кишечнике :{

~аутоинтоксикация, сенсibilизация, булемия
~гипотонический синдром, анорексия
~гипопротеинемия, аллергия
~ ипервитаминозы, высыпания на коже
=аутосенсibilизация, аллергия, интоксикация
}

К чему приводит гипо- и ахолия :{

~замедляется моторика кишечника, развивается метеоризм
~нарушается переваривание и всасывание жиров и витамина В12
~ускоряется моторика кишечника, возникает диарея
~нарушает всасывание углеводов и витаминов группы В
=приводит к атонии, нарушению переваривания и всасывания жиров, холестерина и витаминов Д, Е, А, К.
}

Назовите основные причины поражения органов пищеварения вторичного характера :{

~пищевые отравления
~гипертрофические гастриты
~атрофические гастриты
=уринозный гастроэнтерит
~белковокалорийная недостаточность (несбалансированность диеты).
}

Булемия это :{

- ~понижение аппетита
- ~отказ от пищи
- =избыточное потребление пищи
- ~тошнота
- ~все перечисленное

}

При какой патологии наблюдается гипосаливация :{

- =при сиалоаденитах
- ~при пульпите
- ~при периодонтите
- ~при преобладании тонуса парасимпатической системы
- ~все перечисленное

}

Назовите центральные механизмы рвоты :{

- ~неукротимая рвота беременных
- ~переполнение желудка
- =при повышении внутричерепного давления
- ~недоброкачественная пища
- ~все перечисленное

}

К чему может привести длительная, неукротимая рвота :{

- ~развивается компенсированный ацидоз
- ~развивается декомпенсированный ацидоз
- =развивается ахлоридная кома с явлением алкалоза
- ~метаболическому алкалозу
- ~все перечисленное

}

Eructatio - это :{

- ~рвота

~икота
~изжога
=отрыжка
~тошнота
}

Pyrosis – это :{

~рвота
~икота
~отрыжка
=изжога
~тошнота
}

Singultus – это :{

~рвота
=икота
~отрыжка
~изжога
~тошнота
}

Почему нарушается дуоденальное пищеварение при ахлоргидрии :{

=снижается секреция панкреатического сока
~увеличивается секреция секретина
~увеличивается секреция гастрина
~увеличивается холецистокинин
~увеличивается мотилин
}

Какие нарушения приводят к панкреатической ахилии :{

- ~повышение активности блуждающего нерва
 - ~снижение тонуса симпатической системы
 - ~употребление большого количества углеводной пищи
 - =хронический панкреатит
 - ~все перечисленное
- }

Что такое стеаторея :{

- ~пониженное содержание в кале жира и жирных кислот
 - =повышенное содержание в кале жира и жирных кислот
 - ~повышенное содержание в кале слизи
 - ~повышенное содержание в кале белков
 - ~все перечисленное
- }

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь является результатом :{

- ~наличия дивертикулов в пищеводе
 - ~повышенного тонуса кардиальной части пищевода
 - =расслабления нижнего пищеводного сфинктера
 - ~поражения мышц глотки
 - ~дисфагии
- }

Почему при демпинг - синдроме нередки обморок или понижение А/Д :{

- ~увеличение объема жидкости в кишечнике стимулирует образование адреналина
 - =увеличение объема жидкости в кишечнике стимулирует образование серотонина
 - ~ускорение васывающей глюкозы с гипергликемией
 - ~снижением выработки инсулина
 - ~все перечисленное
- }

Рвота центрального генеза наблюдается :{

~при интоксикациях (экзогенных)

~при лучевой болезни

=при гипертонических кризах

~при интоксикациях (эндогенных)

~все перечисленное

}

Какие ферменты поджелудочной железы расщепляют белки на олигопептиды: {

~липаза

~фосфолипаза A2

~амилаза

=трипсин

~все перечисленное

}

Какие факторы приводят к спастическим запорам :{

=свинцовые отравления, стресс

~обширные полостные операции

~перитониты

~гипо- и ахолия

~все перечисленное

}

Укажите причину динамической непроходимости кишечника :{

~повышение тонуса парасимпатических нервов

=разлитое гнойное воспаление брюшины

~гастроэнтероколиты

~поступление в кишечник непереваренных пищевых масс

~гиперсекреция желез кишечника

}

Какому механизму придают сейчас существенную роль в патогенезе

пептических язв желудка :{
~снижению парасимпатических влияний на
слизистую желудка
~снижению симпатических влияний на
слизистую желудка
~усилению синтеза простагландинов
клетками слизистой оболочки
~все перечисленное
=действию *Helicobacter pylori* на
защитный слой слизистой оболочки
}

Как меняется моторно-эвакуаторная функция желудка при гиперсаливации :{
~моторная замедляется, а эвакуаторная ускоряется
=ускоряются обе функции
~ускоряется моторная, а эвакуаторная замедляется
~замедляются обе функции
~моторно-эвакуаторная функция не Меняется
}

Как меняется моторно-эвакуаторная функция желудка при гастрите с повышенной кислотностью :{
~моторная замедляется, а эвакуаторная ускоряется
=замедляются обе функции
~ускоряется моторная, а эвакуаторная замедляется
~моторно-эвакуаторная функция не меняется
~повышаются и моторная, и эвакуаторная
}

Укажите основные особенности мембранного пищеварения :{
~происходит с участием кишечной микрофлоры
=происходит практически в стерильных условиях
~обеспечивается начальный гидролиз пищевых ингредиентов
~осуществляется преимущественно ферментами поджелудочной железы
~все перечисленное
}

Отличительная особенность мембранного пищеварения от полостного состоит :{

~происходит с участием кишечной микрофлоры

=в высокой сопряженности переваривания и всасывания пищевых субстратов

~обеспечивается начальный гидролиз пищевых ингредиентов

~осуществляется преимущественно ферментами поджелудочной железы

~все перечисленное

}

Отличительная особенность мембранного пищеварения от полостного состоит :{

~в обязательном участии кишечной микрофлоры

=осуществляется ферментами, фиксированными на мембране щеточной каймы кишечника

~обеспечивает начальный гидролиз пищевых ингредиентов

~осуществляется преимущественно ферментами поджелудочной железы

~все перечисленное

}

Укажите возможные причины развития желудочной гипосекреции :{

~избыточная секреция соматостатина

~активная стимуляция парасимпатической системы

=снижение выработки и выделения гастрина

~увеличение активности гистаминазы

~избыточное выделение адреналина

}

Укажите возможные причины развития желудочной гиперсекреции :{

~избыточная секреция соматостатина

=увеличение выработки и выделения гастрина

~снижение выработки и выделения гастрина

~увеличение активности гистаминазы

~избыточное выделение адреналина

}

Назовите наиболее частую причину кишечной аутоинтоксикации :{

- ~снижение секреции желудочного сока
 - ~повышение моторики кишечника
 - =ослабление эвакуаторной функции кишечника
 - ~гиперсекреция панкреатического сока
 - ~гипертрофия микроворсинок тонкой кишки
- }

Назовите наиболее частую причину аутоинтоксикации :{

- ~снижение секреции желудочного сока
 - ~повышение моторики кишечника
 - =ахолия
 - ~гипертрофия микроворсинок тонкой кишки
 - ~гиперсекреция панкреатического сока
- }

Как влияет психическая травма на секрецию желудочного сока и его кислотность :{

- ~повышает секрецию и снижает кислотность
 - ~повышает секрецию и повышает кислотность
 - ~угнетает секрецию и повышает кислотность
 - =угнетает секрецию и снижает кислотность
- }

Ахилия желудка сопровождается :{

- ~отсутствием соляной кислоты
 - ~отсутствием ферментов
 - ~отсутствием соляной кислоты, наличием ферментов
 - =отсутствием соляной кислоты и ферментов
 - ~наличием соляной кислоты и отсутствием ферментов
- }

Назовите причины ослабления желудочной перистальтики :{

- ~повышение активности парасимпатической системы

=понижение активности парасимпатической системы
~сужение пилорического отверстия
~увеличение в крови инсулина
~введение гистамина или ацетилхолина
}

Дивертикул пищевода является результатом :{
~появления выпячивания в стенке из-за ахалазии
~появления выпячивания в стенке из-за халазии
=врожденной недостаточности соединительной ткани
~склеродермии
~сдавления извне аневризмой аорты
}

Чем характеризуется врожденное заболевание – целиакия :{
~непереносимостью продуктов, богатых жиром
~непереносимостью продуктов, богатых белком
=непереносимостью продуктов из злаков
~непереносимостью углеводов
~непереносимостью сбалансированной пищи
}

?Назовите основные причины дисбактериоза кишечника :{
~ожоговая болезнь
~авитаминоз
~лучевое воздействие
=осложнения после терапии антибиотиками
~все перечисленное
}

Чем может осложняться диарея :{
~развитием газового алкалоза
~развитием выделительного алкалоза
~развитием метаболического ацидоза

=развитием выделительного ацидоза
~все перечисленное
}

Укажите одну из причин снижения секреторной активности поджелудочной железы :{
=снижение выработки и выделения холецистокинина
~усиление парасимпатической стимуляции железы
~повышение и выделение холецистокинина
~повышение выработки и выделения секрета
~все перечисленное
}

Укажите симптомы нарушения переваривания углеводов :{
~боли в животе (коликообразные), метеоризм
~диарея, рвота
~рвота, изжога
~запоры и метеоризм
=метеоризм, боли, диарея
}

Укажите заболевания, приводящие к нарушению полостного пищеварения :{
=дуодениты, хронические панкреатиты, механическая желтуха
~язвенная болезнь желудка, болезнь Боткина
~гемолитическая желтуха и гастриты
~гельминтозы и резекция желудка
~сахарный диабет, дизентерия
}

Укажите заболевания, которые могут привести к нарушению мембранного пищеварения :{
=ферментопатии
~хронический панкреатит
~механическая желтуха
~гастриты
~гемолитическая желтуха

}

Ятрогенные "стероидные" язвы вызываются :{

~инсулином

~адреналином

~минералокортикоидами

=глюкокортикоидами

~половыми гормонами

}

Чем характеризуется инертный тип желудочной секреции :{

=замедленным нарастанием секреции и увеличением объема желудочного сока в нейрорхимическую фазу

~полным отсутствием желудочного сока, как в рефлексорной, так и в нейрорхимической фазе

~интенсивным нарастанием секреции в рефлексорной и нейрорхимической фазе

~интенсивным началом в рефлексорной и медленным прекращением в нейрорхимической стадии

~хаотической секрецией независимо от механического или химического раздражения

}

Какой тип желудочной секреции характеризуется резким уменьшением объема желудочного сока :{

=тормозной

~возбудимый

~нормальный

~хаотический

~все перечисленное

}

Какой тип желудочной секреции характеризуется избыточным увеличением объема желудочного сока :{

~тормозной

=возбудимый

~нормальный
~астенический
~инертный
}

Чем характеризуется возбудимый тип желудочной секреции :{
~отсутствием закономерной динамики и объемов секреции на механическое и химическое раздражение
~замедленным нарастанием на механическое и химическое раздражение
=интенсивным нарастанием секреции на механическое и химическое раздражение
~интенсивным началом и быстрым снижением на химическое раздражение
~адекватной секрецией и на механическое, и на химическое раздражение
}

Чем характеризуется тормозной тип желудочной секреции :{
~отсутствием закономерной динамики и объемов секреции на механическое и химическое раздражение
=замедленным нарастанием на механическое и медленным его прекращением на химическое раздражение
~интенсивным нарастанием секреции на механическое и химическое раздражение
~интенсивным началом и быстрым снижением на химическое раздражение
~адекватной секрецией и на механическое, и на химическое раздражение
}

Чем характеризуется астенический тип желудочной секреции :{
~увеличенным латентным периодом, замедленным нарастанием секреции, увеличенным объемом желудочного сока
=укороченным латентным периодом, интенсивным началом и быстрым снижением секреции, малым объемом желудочного сока
~отсутствием какой-либо закономерностей динамики и объемов секреции
~укороченным латентным периодом начала секреции и интенсивным

нарастанием, повышенным объемом желудочного сока
~отсутствием желудочного сока на механическое и химическое раздражение

}

Укажите постренальные причины нарушений функции почек: {
~нервно-психические расстройства
~инфекции
=нарушение оттока мочи при аденоме простаты
~нарушение системного кровообращения
~при уретрите

}

При повреждении проксимальных канальцев нарушается реабсорбция: {
=глюкозы
~Na
~K
~H₂O
~все перечисленное

}

При повреждении проксимальных канальцев нарушается реабсорбция: {
=аминокислот
~Na
~K
~H₂O
~все перечисленное

}

При повреждении дистальных отделов канальцев нарушается реабсорбция: {
~глюкозы
~аминокислот
~бикарбонатов
=Na и K
~все перечисленное

}

Укажите последствия почечнокаменной болезни: {
~нефроз

=гидронефроз
~нефрит
~тубулопатия
~все перечисленное

}

Что такое гиперстенурия : {
~снижение относительной плотности мочи
=повышение относительной плотности мочи
~монотонный диурез
~появление в моче солей мочевой кислоты
~все перечисленное

}

Укажите ренальные причины нарушений функций почек: {
~нервно-психические расстройства
=соли тяжелых металлов
~нарушение общего кровообращения
~сужение почечной артерии
~нарушение оттока мочи

}

Какие нарушения характерны для олигоанурической стадии ОПН: {
~метаболический алкалоз
=увеличение остаточного азота в крови
~гиповолемия
~гипокалиемия
~гипернатриемия

}

При нефротическом синдроме количество белка в крови: {
~не изменяется
~увеличивается
~незначительно уменьшается
=значительно снижается
~незначительно увеличивается

}

Укажите вероятные механизмы, способствующие реальной гипертензии: {
=активация ренин-ангиотензиновой системы
~снижение синтеза ренина
~активация калликреин-кининовой системы

~задержка К в организме
~снижение образования альдостерона

}

При каких заболеваниях почек наблюдается гематурия: {

~при пиелите
~при поликистозе
~при нефрозе
=при пиелонефрите
~все перечисленное

}

Укажите патологические компоненты мочи ренального происхождения: {

~непрямой билирубин
~стеркобилин
~уробилин
=цилиндры
~желчные кислоты

}

Недостаток каких гормонов может вызвать полиурию: {

~соматотропина
~адреналина
~окситоцина
=альдостерона
~все перечисленное

}

Какие изменения в моче характерны для нефритического синдрома: {

~глюкозурия
~кетонурия
~ацетонурия
=микрогематурия
~макрогематурия

}

Какие изменения в моче характерны для нефритического синдрома {

~глюкозурия
~кетонурия
=цилиндрурия
~ацетонурия
~макрогематурия

}

Чем объясняется гипертензия при хроническом диффузном: {
гломерулонефрите
=снижением выработки почками простагландинов E
~повышением выработки почками простагландинов E
~повышением выработки почками кининов
~снижением выработки почками кининов
~все перечисленное
}

Назовите признаки, свидетельствующие о нарушениях ультрафильтрации в почках: {
~аминоацидурия
~глюкозурия
~уробилинурия
=протеинурия
~все перечисленное

}

Олигурия – это: {
~увеличение количества мочи
=уменьшение диуреза
~болезненное мочеиспускание
~преобладание ночного диуреза над дневным
~отсутствие мочи

}

Укажите механизмы глюкозурии: {
~повышение фильтрационного давления
=блокирование гексокиназы в канальцах
~повреждение клубочков
~падение гидростатического давления
~ацидоз

}

Полиурия возникает при: {
=усилении клубочковой фильтрации
~повышении реабсорбции в канальцах
~снижении клубочковой фильтрации

~усилении канальцевой реабсорбции
}

Какие заболевания почек относятся к группе иммунных нефропатий: {
=гломерулонефрит
~поликистоз почек
~мочекаменная болезнь
~пиелонефрит
~все перечисленное
}

Укажите механизмы снижения клубочковой фильтрации: {
=снижение артериального гидростатического давления
~усиление канальцевой реабсорбции
~повышение артериального давления
~понижение коллоидно - осмотического давления плазмы
~все перечисленное
}

Какие вещества накапливаются в крови при снижении скорости клубочковой фильтрации: {
~глюкоза
=креатинин
~билирубин
~стеркобилин
~молочная кислота
}

Каков диурез при вторичном гиперальдостеронизме: {
~увеличен
=уменьшен
~неизменен
~незначительно увеличен
~незначительно уменьшен
}

Укажите вероятные причины олигурии: {
~холемиа
~гипергликемия

~гиперадреналинемия
=гипопротеинемия
~все перечисленное

}

Укажите вероятный механизм поражения клубочков при гломерулонефрите:

{

~лекарственный
~нарушение коркового кровообращения
=поражение базальной мембраны иммунными комплексами
~нарушение оттока мочи
~сужение почечной артерии

}

Как влияет повышение онкотического давления крови на клубочковую фильтрацию: {

~увеличивает
=снижает
~не снижает
~слегка увеличивает
~слегка снижает

}

Снижение онкотического давления крови: {

=увеличивает фильтрацию
~снижает фильтрацию
~не изменяет фильтрацию
~незначительно увеличивает фильтрацию
~незначительно снижает фильтрацию

}

Как изменяется фильтрация в клубочках при повышении давления в капсуле Боумена-Шумлянского: {

~повышается
=понижается
~не изменяется
~незначительно повышается
~незначительно понижаются

}

Назовите эндогенные факторы, способствующие нефролитиазу: {

- ~гипофункция околощитовидной железы
- =гиперфункция околощитовидной железы
- ~повышение количества тиреокальцитонина в крови
- ~снижение в крови тироксина
- ~все перечисленное

}

Укажите причины тубулопатии :{

- =поражение канальцев
- ~почечный несахарный диабет
- ~поражение клубочков
- ~воспаление мочеточников
- ~цистит

}

Какие грозные осложнения возникают на фоне олиго- и анурии в организме:

{

- ~застой в печени
- ~асцит
- =отек легких
- ~внутричерепное давление
- ~все перечисленное

}

Укажите наиболее частую причину смерти больных при ХПН: {

- ~уремический гастрит, энтерит
- ~нарушение свертывающей функции крови
- ~паралич дыхания
- =расстройства функций сердечно-сосудистой системы
- ~все перечисленное

}

Укажите причины развития анемии при заболеваниях почек: {

- ~гемолиз эритроцитов
- ~кровопотери
- =снижение синтеза эритропоэтинов
- ~потеря аминокислот
- ~недостаток Fe, Cu, Ni

}

Какие причины приводят к ренальной ОПН: {

~острая сосудистая недостаточность

~сепсис

~обструкция мочевыводящих путей

=острый гломерулонефрит

~гиперволемиа

}

Какие причины приводят к ренальной ОПН: {

=соли тяжелых металлов

~острая сосудистая недостаточность

~сепсис

~гиперволемиа

~обструкция мочевыводящих путей

}

Какие причины приводят к преренальной ОПН: {

~соли тяжелых металлов

=эмболия почечной артерии

~мочекаменная болезнь

~обструкция мочевыводящих путей

~сепсис

}

При внепочечной гематурии эритроциты: {

~выщелоченные

=свежие

~секвестированные

~поврежденные

~все перечисленное

}

Что является ведущим признаком нефроза: {

~лейкоцитурия

~гематурия

=протеинурия

~гипертония

~гипотония

}

Для нефротического синдрома характерны: {

=высокая протеинурия

~низкая протеинурия

~гиперальбуминемия

~отсутствие отеков

~гиполипидемия

}

Гиповолемия может привести: {

~к усилению фильтрации

=к уменьшению фильтрации

~фильтрация не изменяется

~к увеличению реабсорбции

~все перечисленное

}

Боль приводит: {

~к увеличению диуреза

~диурез не изменяется

=к снижению диуреза

~к снижению реабсорбции

~к повышению реабсорбции

}

В начальную стадию ОПН диурез: {

~уменьшен

=не изменен

~увеличен

~незначительно уменьшен

}

Третья стадия ОПН характеризуется: {

~олигурией

~анурией

=полиурией

~не изменены

~никтурией

}

Никтурия – это: {

~появление в моче эритроцитов

~частое мочеиспускание в дневное время

~болезненное мочеиспускание

=преобладание диуреза в ночное время

~редкое мочеиспускание в дневное время

}

Укажите вероятные механизмы, способствующие ренальной гипертензии: {

=активация ренин - ангиотензиновой системы

~снижение синтеза ренина

~активация калликреин-кининовой системы

~снижение образования альдостерона

~задержка К в организме

}

Укажите патологические компоненты мочи ренального происхождения: {

~непрямой билирубин

~стеркобилин

~уробилин

=белок в большом количестве

~желчные кислоты

}

Поллакурия – это: {

~появление в моче эритроцитов

=частое болезненное мочеиспускание

~редкое болезненное мочеиспускание

~усиление диуреза в ночное время

~уменьшение диуреза в дневное время

}

Олакизурия-это: {

~появление в моче эритроцитов

~частое болезненное мочеиспускание

=редкое болезненное мочеиспускание

~появление в моче зернистых цилиндров

~появление в моче гемоглобиновых цилиндров

}

Недостаток каких гормонов может вызвать полиурию: {

~соматотропина

~адреналина

~окситацина

=альдостерона

~сочетание 1, 2.

}

Олигурия – это: {

~увеличение количества мочи

=уменьшение диуреза

~болезненное мочеиспускание

~преобладание ночного диуреза над дневным

~отсутствие мочи

}

Полиурия возникает при: {

~снижении гидростатического давления в клубочках

~повышении реабсорбции в канальцах

~снижении клубочковой реабсорбции

=уменьшении канальцевой реабсорбции

~повышении выделения АДГ

}

Какие изменения в моче характерны для нефритического синдрома: {

~глюкозурия

~протеинурия

~гематурия

~сочетание 1, 2.

=сочетание 2, 3.

}

Какие факторы могут вызвать анурию: {

~лихорадка

- =боль
- ~денервация почки
- ~гипертонический криз
- ~пиелонефрит

}

Что такое уремический синдром: {

- ~гематурия
- =появление составных частей мочи в крови
- ~увеличение билирубина в моче
- ~увеличение холестерина в крови
- ~уменьшение билирубина в моче

}

Сколько образуется первичной мочи за сутки: {

- ~20-130 л.
- ~130-140 л.
- =150-170 л.
- ~больше 120 л.

}

Об анурии говорят в том случае, когда суточный диурез у больного не превышает: {

- ~1. 100мл
- =2. 50мл.
- ~3. 150 мл.
- ~4. 200 мл.
- ~5. 90 мл.

}

К неиммунным нефропатиям относятся: {

- ~ревматизм
- ~системная красная волчанка
- ~узелковый периартрит
- =метаболический (подагра)
- ~гломерулонефрит

}

Каковы клинические проявления стадии олигурии при ОПН: {

- ~Отёк головного мозга

~лихорадка
~коллапс
~диарея
=кома

}

Какие причины приводят к преренальной ОПН: {

~соли тяжелых металлов
=острая сосудистая недостаточность
~мочекаменная болезнь
~обструкция мочевыводящих путей
~сепсис

}

Укажите причины постренальной ОПН: {

~Соли тяжелых металлов
~острая сосудистая недостаточность
~обезвоживания
=обструкция мочевыводящих путей
~сепсис

}

Назовите основные причины никтурии: {

~ангиоспазм почечной артерии
~нефроз
=уретрит или цистит
~пиелит
~сочетание 1, 2

}

Изостенурия - это: {

~увеличение удельного веса мочи
~появление в моче эритроцитов
=монотонный малый удельный вес
~сочетание 1, 3, 4.

}

